



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نادية السيد عبد الفتاح محمد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 28609140102342 رقم التليفون : 01127741923
العمر (تاريخ الميلاد) : 14-09-1986 المهنة : ربه منزل
العنوان : منشيه جمال عبد الناصر
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي
الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]
التعليق على التشخيص : -----
قسم العلاج : الاورام

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نادية السيد عبد الفتاح محمد National ID: 28609140102342	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



لاديه
السيد عبد الفتاح محمد
٥٢ ش ٢٥ منشية جمال عبدالناصر
حلوان - القاهرة

٢٨٦٠٩١٤٠١٠٢٣٤٢

1Q8116299

٢٠٢٠/١١ ٢٨٦٠٩١٤٠١٠٢٣٤٢



ربة منزل
أنثى
مسلمة
متزوجة
اسمها جمعة عبد التواب السيد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١١/١٨

١





MDT FORM

6/11/2025 G

Name	د. رانيا / رانيا	MRN	397125
Age	38	ID	C.A. 914.1.444
Menopausal status		Phone	0127741923
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	no
CO morbidity	Free	REASON OF MDT	post op

Clinical Data

BX:	Ut Inx 6 II				
ER:	8/8	PR:	5/8	HER 2:	+3
				KI67:	60%
Sonomammography:					
Mets Workup:					

R

L



TNM

Recommendations:

U MRM (post NACT)
- no residual viable remnants
- DCIS → absent
- deep margin → free

- nipple, areola → free
- axillary LNs → 0/12
- complete pathological response
- ypT0, ypN0

MDT OUTCOME & PLAN

① Continue pharago for 2/12/25
② PORT

③ Post

SIGNATURE

ET (TAM + Zoladex)

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. رانيا / رانيا	د. رانيا / رانيا	د. رانيا / رانيا			

Patient Name : الأمينة / شادية السيد عبدالفتاح محمد	Request No. : 13003647
Patient No. : 28609140102342	Request Date : 13/01/2025
Path No. : 158/25	Verification Date : 01/02/2025
Sex : Female	Financial Category : مريضات - مريضات
Age : 38 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast swelling.

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected at 13/1/2025.

Gross Examination:

Multiple grey white tissue cores measured up to 1 cm, totally submitted.

Microscopic examination:

Cores of breast tissue show periductal inflammation with minimat / presented atypical intraductal proliferation. Two strips of skin fragments are seen.

Diagnosis:

Left breast swelling, tru cut biopsy:

- Minimally presented atypical intraductal proliferation. For mandatory marker study (P63, Calponin).

Dr. Marwa Mahmoud

Dr. Nermin Muhammed

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 26/02/2025 12:47:34

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name : الأستاذة / نادية السيد عبدالفتاح محمد	Request No. : 13005776
Patient No. : 28609140102342	Request Date : 12/10/2025
Path No. : 3106/25	Verification Date : 20/10/2025
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 39 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.

Nature of specimen: Left modified radical mastectomy.

Gross Examination:

- * Left modified radical mastectomy specimen measured 26x26x5 cm, with covering skin measured 20x15 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
- * Serialing showed a tumor bed site 7x6x3 cm, located 2 from the least deep margin.
- * Axillary fat measured 8x7x2 cm, entangling 12 lymph nodes, the largest was 1.5x1x0.5 cm.
- * 13 Blocks:
- 1:7- T.B.S., 8- N&A., 9- Deep margin., 10:13- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Cellularity (0%).
- * Angioinvasion: Absent.
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Microcalcification: Present.
- * Nipple & areola: Free.
- * Deep margin: Free.
- * Axillary lymph nodes: Twelve lymph nodes showing effect of therapy with no viable metastatic deposits (0/12).
- * Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:

Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy:

- No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Ductal carcinoma in situ: Absent.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed



Patient Name	: الأستاذة / نادية السيد عبدالفتاح محمد	Request No.	: 13005776
Patient No.	: 28609140102342	Request Date	: 12/10/2025
Path No.	: 3106/25	Verification Date	: 20/10/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوسالف روسي - نفقة الدولة
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Deep Margin: Free.
- Nipple & areola: Free.
- Axillary lymph nodes: Twelve lymph nodes showing effect of therapy with no viable metastatic deposits (0/12).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
- Stage: ypT0, ypN0.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 20/10/2025 10:35:51

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



خرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Nadia Al Sayed Abdel Fattah Mohamed	Date : 06/09/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 158/2025	Pat. ID: 96797

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after neoadjuvant chemotherapy of pathologically proved left breast carcinoma.

- Breast density: Moderate dense breast tissue . *Breast density matches ACR C.*
- Thickened left breast skin with underlying global asymmetry .
- No detected suspicious mass density, architectural distortion or pathological micro-calcification.
- Normal skin and nipple.

By complementary breast ultrasound:

- Thickened left breast skin measuring 15 mm in its max thickness with underlying interstitial edema.
- Shast of parenchymal infiltration extending roughly for distance of 9 cm being more evident in the left upper outer quadrant .
- No detected suspicious masses in the right breast .
- Normal skin, subcutaneous fat and nipple areola complex on both sides.
- Multiple (more than 3 in number) suspicious looking level 1 & 2 left axillary LN's the largest measures (23 x 9 mm) with thick cortex of 5 mm.

Conclusion:

- Comparing to the previous radiological datafindings are suggestive of stable disease (SD) (BIRADS 6 category).
- Normal study of the right breast (BIRADS 1 category).

Much Oblige

DR.MONA ZAKY.MD

professor-Breast imaging-Mansoura university



Patient Name: Nadia Al Sayed Abdel Fattah Mohamed	Date : 26/03/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 397/2025	Pat. ID: 96797

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS:**

- Reported case of left breast cancer.

I Chest:

- Left breast diffuse skin thickening and asymmetrical parenchymal densities as well as enlarged left axillary level I and II lymph nodes reaching 2.4 X 1.9 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- Few left ovarian cysts mostly functional.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

Reported case of breast cancer revealed:

- No sizable hepatic or pulmonary metastatic lesions.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.